



Revue générale des douleurs cervicales et lombaires

Par **Peter J. Moley**, MD, Hospital for Special Surgery
Reviewed By **Brian F. Mandell**, MD, PhD, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University
Vérifié/Révisé nov. 2024

Les douleurs du cou et du dos sont parmi les causes les plus fréquentes de consultations médicales.

Physiopathologie des douleurs cervicales et lombaires

En fonction de la cause, les douleurs du cou ou dorsales ou lombaires peuvent être accompagnées de symptômes neurologiques.

Si une racine nerveuse est atteinte, la douleur peut irradier distalement dans le territoire de distribution de cette racine (douleur radiculaire). La force musculaire, la sensibilité et les réflexes de la région innervée par ces racines peuvent être altérés. (voir [Comment évaluer les réflexes.](#))

TABLEAU	
Symptômes de radiculopathies fréquentes selon le dermatome	
Niveau	Symptômes
C4	Douleur de la région inférieure du cou et du trapèze avec paresthésies touchant la partie inférieure du cou et la ceinture scapulaire supérieure
C5	Douleur au niveau du cou, de l'épaule et de l'avant-bras dorsal avec paresthésies et engourdissements touchant la partie dorsale du bras Faiblesse du deltoïde, du biceps, de la coiffe des rotateurs Diminution du réflexe bicipital

Niveau	Symptômes
C6	Douleur au bord du trapèze et à la pointe de l'épaule, irradiant souvent vers le pouce et l'index, avec des paresthésies et un engourdissement des mêmes zones Faiblesse des extenseurs du poignet Diminution du réflexe brachioradial et du pronator teres
C7	Douleur, paresthésies et engourdissements dans la région de l'omoplate et de la fosse axillaire, irradiant vers le medius et l'annulaire Déficit du triceps Diminution du réflexe tricipital
T1	Engourdissement et picotements dans l'avant-bras médial proximal Possible faiblesse légère de la main
T2-T12	Dysesthésies en bande autour du thorax (p. ex., mamelon T6 et ombilic T10)
L1-L2	Douleur, engourdissement et paresthésies de la partie antérieure proximale et médiale de la cuisse Faiblesse des fléchisseurs de la hanche
L3	Douleur, engourdissement et paresthésies de la cuisse et du genou antérolatéraux avec faiblesse du quadriceps et diminution du réflexe rotulien
L4	Douleur, engourdissement et paresthésies de la partie postérolatérale de la cuisse et de la partie antérieure de la jambe, faiblesse de la dorsiflexion des chevilles et diminution du réflexe rotulien

Niveau	Symptômes
L5	Douleur dans la fesse, la face postéro-latérale de la cuisse, la partie antérolatérale de jambe et la partie dorsale du pied Chute du pied avec déficit de l'extenseur hallucis longus et des muscles tibial antérieur et péroniers Réflexe ischio-jambier diminué Douleur, engourdissement et paresthésies de la jambe et de la face dorsale du pied
S1	Douleur le long de la face postérieure de la cuisse, de la jambe et de la fesse Faiblesse du muscle gastrocnémien avec flexion plantaire de la cheville altérée Perte du réflexe achilléen Engourdissements et paresthésies des faces latérales du mollet, de la cheville et du pied

Si la moelle épinière est atteinte, la force, la sensibilité et les réflexes peuvent être altérés au niveau de la zone atteinte de la moelle épinière et touchera tous les niveaux sous-jacents (appelés déficits neurologiques systématisés).

Lorsque la queue-de-cheval est lésée, des déficits segmentaires se développent dans la région lombosacrée, généralement avec trouble de la fonction sphinctérienne anale ([constipation](#) ou [incontinence fécale](#)) et de la fonction vésicale ([rétention urinaire](#) ou [incontinence urinaire](#)), troubles sensitifs de la région périanale, [troubles de l'érection](#) et perte du tonus rectal et du contrôle sphinctérien rectal (p. ex., réflexes bulbocaverneux, et réflexe anal).

Tout phénomène douloureux de la colonne vertébrale peut également provoquer un réflexe (contracture) des muscles paravertébraux.

Étiologie des douleurs cervicales et lombaires

La plupart des douleurs du cou, des dorsalgies et des lombalgies sont provoquées par des troubles du rachis. La douleur musculaire est un symptôme fréquent et est généralement causée par une irritation des muscles profonds par les branches dorsales du nerf spinal et des muscles plus superficiels résultant d'une réaction locale à la lésion de la colonne vertébrale. Les entorses sont très rares dans la région

cervicale et le rachis lombaire. Une [fibromyalgie](#) peut coexister avec des douleurs du cou et du dos mais est moins susceptible de causer des douleurs isolées au cou ou au dos. Parfois, la douleur est due à des [troubles extrarachiens](#) (en particulier des troubles vasculaires, digestifs ou génito-urinaires) ou à une herpès zoster. Certaines causes rares, spinales et extra-spinales, sont graves.

La plupart des troubles rachidiens résultent de

- Problèmes mécaniques

Seuls quelques-uns impliquent des problèmes non mécaniques, tels qu'une infection, une inflammation, un cancer ou des fractures de fragilité dues à une [ostéoporose](#).

Colonne vertébrale et moelle épinière



Causes habituelles

La plupart des douleurs causées par des troubles mécaniques de la colonne vertébrale sont des

- Douleurs discales
- Douleurs des racines nerveuses
- [Arthrites](#) des articulations

Les causes les plus fréquentes de douleurs au cou et au bas du dos sont les suivantes.

- [Hernie discale](#)
- [Fracture par tassement](#) (habituellement thoracique ou lombaire)
- [Canal lombaire et cervical étroit](#)
- [Arthrose](#) de tout le rachis
- [Spondylolisthésis](#)

Tous ces troubles peuvent également être présents sans causer de douleur.

Plusieurs anomalies anatomiques (p. ex., [bombement ou dégénérescence du disque](#), ostéophytes, spondylolyse, anomalies des articulations facettaires) sont fréquemment présents chez les sujets qui n'ont pas de douleurs cervicales ou dorsales et sont donc discutables comme l'étiologie de la douleur. Cependant, l'étiologie des douleurs du dos, en particulier si elles sont mécaniques, est souvent multifactorielle, avec des troubles sous-jacents exacerbés par la fatigue, le déconditionnement

physique, les douleurs musculaires, les mauvaises postures, la faiblesse des muscles stabilisateurs, la diminution de la flexibilité et parfois le stress psychosocial ou un trouble de santé mentale. Ainsi, identifier une cause unique est souvent difficile ou impossible, en particulier dans le contexte d'une douleur chronique.

Un syndrome de douleur myofasciale généralisée, tel que la [fibromyalgie](#), comprend souvent des douleurs du cou et/ou du dos.

Causes graves et rares

Certaines sont très sérieuses et nécessitent un traitement précoce pour éviter un handicap ou le décès.

Les troubles graves **extrarachiens** sont les suivants:

- [Anévrisme de l'aorte abdominale](#)
- [Dissection aortique](#)
- Dissection de l'artère vertébrale ou de la carotide
- [Méningite aiguë](#)
- [Angor](#) ou [infarctus du myocarde](#)
- Certains troubles gastro-intestinaux (p. ex., [cholécystite](#), [diverticulite](#), abcès diverticulaire, [pancréatite](#), [ulcère gastroduodénal](#), [appendicite](#) rétrocaecale)
- Certains troubles pelviens (p. ex., [grossesse extra-utérine](#), [cancer de l'ovaire](#), salpingite (voir [Maladie pelvienne inflammatoire](#)))
- Certains troubles pulmonaires (p. ex., [pleurésie](#), [pneumonie](#))
- Certains troubles des voies urinaires (p. ex., [prostatite](#), [pyélonéphrite](#), [néphrolithiase](#))
- Métastases de cancer extraspinal
- Troubles rétropéritonéaux inflammatoires ou infiltrants (p. ex., fibrose rétropéritonéale, [maladie liée aux immunoglobulines G4 \[IgG4-RD \(Ig4-related disease\)\]](#), hématome, adénopathie)

Les troubles graves du **rachis** comprennent les suivants:

- Infections (p. ex., spondylodiscite, abcès épidural, [ostéomyélite](#))
- Tumeurs primitives ([de la moelle épinière ou des vertèbres](#))
- Tumeurs métastatiques vertébrales (le plus souvent des seins, des poumons ou de la prostate)

Les troubles mécaniques rachidiens peuvent être graves lorsqu'ils compriment les racines nerveuses ou, en particulier, la moelle épinière. La [compression de la moelle épinière](#) ne se produit qu'au niveau de la colonne cervicale, thoracique et lombaire haute et peut résulter d'une sténose spinale sévère ou de tumeurs, d'un [abcès épidural médullaire](#) ou d'un hématome. La compression nerveuse se produit souvent au niveau d'une hernie discale paracentrale ou dans le trou de conjugaison d'un nerf sortant.

Autres causes peu fréquentes

Les douleurs du cou ou du dos peuvent résulter de nombreux autres troubles, tels que

- [Maladie osseuse de Paget](#)
- [Torticolis](#)
- [Syndrome du défilé des scalènes](#)
- [Syndrome de l'articulation temporomaxillaire](#)
- [Zona](#) (avant même l'éruption)
- Les spondylarthropathies ([la spondylarthrite ankylosante](#), l'arthrite entéropathique, le [rhumatisme psoriasique](#), les [arthrites réactionnelles](#) et la spondylarthropathie indifférenciée)
- [Lésion ou inflammation du plexus brachial ou lombaire](#) (p. ex., syndrome de Turning Parsonage)

Évaluation des douleurs cervicales et lombaires

Généralités

La cause des douleurs du cou ou du dos étant souvent multifactorielle, un diagnostic de certitude ne peut être établi chez de nombreux patients. Cependant, les médecins doivent déterminer les éléments suivants si possible:

- La douleur a une cause rachidienne ou extrarachidienne
- La cause est un trouble grave

Si des causes graves ont été exclues, le mal de dos est parfois classé comme suit:

- Lombalgie ou cervicalgie non spécifique
- Cervicalgie ou lombalgie avec symptômes radiculaires
- Sténose rachidienne lombaire avec claudication (neurogène) ou sténose cervicale avec myélopathie
- Lombalgie ou cervicalgie associée à une autre cause rachidienne

Anamnèse

L'**anamnèse de la maladie actuelle** doit comprendre la qualité, le début, la durée, la sévérité, la localisation, l'irradiation, l'évolution de la douleur et les facteurs atténuants et exacerbants tels que le repos, l'activité, les changements de position, le soutien du corps et le moment du jour (p. ex., la nuit, au réveil). Il faut noter les symptômes accompagnants dont la raideur, un engourdissement, des paresthésies, une faiblesse musculaire, une [rétention ou une incontinence urinaire](#), une [constipation](#), et une [incontinence fécale](#).

La **revue des systèmes** doit rechercher des symptômes suggérant une cause dont une fièvre, des sueurs et des frissons (infection); un amaigrissement et un mauvais appétit (infection ou cancer); une aggravation des douleurs du cou lors de la déglutition (troubles œsophagiens); une anorexie, des

nausées, des vomissements, un méléna ou des rectorragies, et des troubles du transit ou des selles (troubles gastro-intestinaux); des symptômes urinaires, une hématurie et des douleurs de l'hypochondre (troubles des voies urinaires), en particulier en cas de coliques intermittentes et récurrentes ([néphrolithiase](#)); une toux, une dyspnée s'aggravant pendant l'inspiration (maladies pulmonaires); un saignement ou une sécrétion vaginale et des douleurs liées au cycle menstruel (pathologies pelviennes); une fatigue, des symptômes dépressifs et des céphalées (douleurs dorsales ou cervicales mécaniques multifactorielles).

La **recherche des antécédents médicaux** comprend des troubles connus du cou ou du dos (dont une [ostéoporose](#), une [arthrose](#), des troubles discaux, des blessures récentes ou anciennes) et des interventions chirurgicales, des facteurs de risque de troubles du dos (p. ex., cancers, dont ceux du sein, de la prostate, des reins, des poumons et du côlon, ainsi que les leucémies), facteurs de risque d'anévrisme (p. ex., tabagisme, HTA), et des facteurs de risque d'infections (p. ex., immunosuppression; toxicomanie par injection; intervention chirurgicale récente, hémodialyse, plaie pénétrante ou infection bactérienne récente); et les signes extra-articulaires d'un trouble systémique sous-jacent (p. ex., diarrhée ou douleur abdominale, uvéite, psoriasis).

Examen clinique

La température et l'état général sont notés. Lorsque cela est possible, pour évaluer la marche et l'équilibre, les patients doivent être vêtus d'une blouse et observés lorsqu'ils se déplacent dans la salle d'examen, marchent, se balancent sur une jambe et montent sur la table d'examen.

L'examen se concentre sur le rachis et l'examen neurologique. Si aucune source mécanique rachidienne de la douleur n'est évidente, on doit rechercher des sources de douleur projetée.

Comment examiner le dos

VIDÉO

Examen du dos

Lors de l'**examen du rachis**, le dos et le cou sont inspectés à la recherche de toute déformation visible, de toute zone cutanée érythémateuse ou vésiculaire. La colonne vertébrale et les muscles

paravertébraux sont palpés pour détecter une sensibilité et un changement du tonus musculaire.

L'amplitude des mouvements est mesurée. Chez les patients souffrant de douleurs au cou, les épaules sont examinées. Chez les patients souffrant de lombalgie, les hanches sont examinées.

Comment examiner le cou

VIDÉO

Examen du cou

L'**examen neurologique** doit évaluer la fonction de la moelle épinière dans sa globalité. La force, la sensibilité et les réflexes ostéotendineux sont testés. Ces tests des réflexes sont parmi les plus fiables qui permettent de confirmer une fonction normale de la moelle épinière. Un dysfonctionnement de la voie corticospinale est indiqué par une élévation des gros orteils en réponse à une stimulation plantaire et par le signe de Hoffman au niveau de la main, le plus souvent par une hyperréflexie.

Pour rechercher le signe de Hoffman, on donne un petit coup sur l'ongle ou une chiquenaude sur la face palmaire du 3e doigt; lorsque la phalange distale du pouce fléchit, le test est positif, témoignant habituellement d'un dysfonctionnement de la voie corticospinale provoqué par une sténose de la moelle cervicale ou une lésion cérébrale. Les troubles de la sensibilité sont subjectifs et peuvent être peu fiables.

Le test de l'élévation de la jambe tendue (test de Lasègue) permet de confirmer la radiculopathie lombosacrée. Le patient est couché avec deux genoux en extension et des chevilles dorsifléchies. Le médecin soulève lentement la jambe atteinte, conservant le genou en extension. En cas de radiculopathie lombosacrée, 10 à 60° d'élévation déclenchent typiquement les symptômes douloureux.

Dans le test de Lasègue croisé, on soulève d'abord la jambe en extension du côté sain; le test est positif si la radiculopathie lombosacrée se produit du côté atteint. Un test de relèvement de la jambe droite positif (signe de Lasègue) est sensible mais non spécifique de la hernie discale; le test de la jambe en extension croisée est moins sensible que le test de Lasègue mais est spécifique à 90%.

Le test de Lasègue assis (slump test) est effectué alors que le patient est assis avec l'articulation de la hanche fléchie à 90°; la partie inférieure de la jambe est lentement relevée jusqu'à ce que le genou soit

en extension complète. En cas de radiculopathie lombosacrée, la douleur rachidienne (et souvent des symptômes radiculaires) se manifeste lorsque la jambe est en extension. Le slump test est similaire au test de Lasègue en appliquant une traction sur les racines nerveuses spinales, mais il est effectué lorsque le patient est affaissé (avec le rachis thoracique et lombaire fléchis) et le cou fléchi lorsque le patient est assis. Le slump test est plus sensible, mais moins spécifique, de la hernie discale que le test de levée de la jambe en extension (Lasègue).

Au cours de l'**examen général**, les poumons sont auscultés. L'abdomen est palpé à la recherche d'une défense ou d'une masse sensible, et, en particulier chez les patients de > 55 ans, d'une masse pulsatile (ce qui suggère un [anévrisme de l'aorte abdominale](#)). La palpation profonde poing fermé des fosses lombaires recherche une sensibilité ou une défense suggérant une [pyélonéphrite](#).

Le **toucher rectal** et l'examen des selles rechercheront la présence de sang et, chez l'homme, un examen de la prostate, sera effectué. Le tonus et les réflexes rectaux sont évalués. Chez la femme qui présente des symptômes évoquant une affection pelvienne ou une fièvre inexplicquée, un [examen pelvien](#) doit être effectué.

Les pouls des membres inférieurs sont palpés.

Signes d'alarme

Les signes suivants sont particulièrement préoccupants:

- Aorte abdominale de diamètre > 5 cm (en particulier si elle est douloureuse) ou en cas d'anomalies ou d'abolition des pouls des membres inférieurs
- Douleur aiguë, à type de déchirure du haut et du milieu du dos
- Cancer, diagnostiqué ou suspecté
- Déficit neurologique
- Fièvre ou frissons
- Des troubles gastro-intestinaux tels qu'une sensibilité abdominale localisée, des signes péritonéaux, un méléna ou une rectorragie
- Facteurs de risque d'infection (p. ex., immunosuppression; toxicomanie IV; intervention récente, plaie pénétrante ou infection bactérienne)
- Méningisme
- Douleur majeure nocturne ou invalidante
- Perte de poids inexplicquée

Interprétation des signes

Bien que des troubles extrarachidiens graves (p. ex., cancers, [anévrismes aortiques](#), abcès péri-duraux, [ostéomyélite](#)) soient des causes inhabituelles de douleurs du dos, ils ne sont pas rares, en particulier dans les groupes à risque élevé.

La présence de signes d'alarme doit faire suspecter une cause grave (voir tableau [Interprétation des signes d'alarme en cas de douleurs du dos](#)).

TABLEAU

Interprétation des signes d'alarme en cas de douleurs du dos

Signes	Causes à évoquer
Aorte abdominale de diamètre > 5 cm (en particulier si elle est douloureuse) ou en cas d'anomalies ou d'abolition des pouls des membres inférieurs	Anévrisme de l'aorte abdominale
Douleur aiguë, à type de déchirure du haut et du milieu du dos	Dissection de l'aorte thoracique
Cancer, diagnostiqué ou suspecté	Métastases
Durée de la douleur > 6 semaines	Cancer Infection subaiguë Spondylarthropathie
Fièvre	Cancer Infection
Troubles gastro-intestinaux tels qu'une sensibilité abdominale localisée, des signes péritonéaux (douleur à la décompression, rigidité de la paroi abdominale), un méléna ou une rectorragie	Possible urgence digestive (p. ex., péritonite, abcès, hémorragie gastro-intestinale)
Facteurs de risque d'infection (p. ex., immunosuppression; toxicomanie IV; intervention récente, plaie pénétrante ou infection bactérienne)	Infection
Méningisme	Méningite
Déficit neurologique	Compression de la moelle épinière ou des racines nerveuses
Douleur majeure nocturne ou invalidante	Cancer Infection
Perte de poids inexpliquée	Cancer Infection subaiguë

Les autres signes sont également utiles. Des douleurs s'aggravant au cours de la flexion évoquent une lésion du disque intervertébral; l'aggravation lors de l'extension suggère une [sténose canalaire](#), une

arthrose ou une inflammation affectant les articulations facettaires. La sensibilité de certaines zones spécifiques (les zones gâchettes) évoque une douleur musculaire causée par un trouble de la colonne vertébrale. Une douleur généralisée et une allodynie non localisée suggèrent un trouble central de la douleur.

Examens complémentaires

Habituellement, si la durée de la douleur est courte (< 4 à 6 semaines), aucun test n'est nécessaire sauf si des signes d'alarme sont présents, en cas de lésion grave (p. ex., accident de la route, chute de hauteur, plaie pénétrante) et si le bilan évoque une cause spécifique non mécanique (p. ex., une [pyélonéphrite](#)).

Les radiographies permettent d'identifier la plupart des pertes de hauteur de disque, les spondylolisthésis antérieurs, les désalignements, les [fractures \(ou les fragilités\) ostéoporotiques](#), [l'arthrose](#) et d'autres anomalies osseuses graves (p. ex., dues à une infection ou à une tumeur); elles peuvent être utiles pour indiquer d'autres imagerie telles qu'une IRM ou une TDM. Cependant, elles n'identifient pas les anomalies des tissus mous (les disques) ou du tissu nerveux (comme cela se produit dans de nombreux troubles graves).

Les examens complémentaires sont guidés par les examens cliniques et les causes suspectées. Des examens complémentaires sont également indiqués en cas d'échec du traitement initial ou si les symptômes se sont modifiés. Les tests de causes suspectes spécifiques comprennent les éléments suivants:

- Déficits neurologiques, en particulier ceux compatibles avec une [compression de la racine nerveuse](#) ou une [compression de la moelle épinière](#): IRM ou myélo-TDM effectuées dès que possible
- Infection possible: numération des globules blancs, vitesse de sédimentation érythrocytaire et/ou CRP (C-reactive protein [protéine C réactive]), imagerie (habituellement IRM ou TDM) et culture des tissus infectés
- Possible cancer: TDM ou IRM, numération formule sanguine et éventuellement biopsie
- Possible [anévrisme](#): TDM, angiographie ou parfois échographie
- Possible [dissection aortique](#): angiographie, TDM ou IRM
- Symptômes invalidants ou qui persistent depuis > 6 semaines: imagerie (habituellement IRM ou TDM) et, si une infection est suspectée, numération des globules blancs, VS et/ou CRP; certains commencent par des radiographies de face et de profil de la colonne vertébrale pour localiser et parfois diagnostiquer des anomalies.
- Autres troubles extramédullaires: effectuer les examens appropriés (p. ex., radiographie de thorax en cas de maladies pulmonaires, analyse d'urine en cas de troubles des voies urinaires ou en cas de douleur dorsale sans cause mécanique claire)

Il est important de noter que les signes d'imagerie ne sont pas toujours corrélés avec les symptômes du patient. Il est démontré que de nombreux patients présentant des hernies discales sont asymptomatiques ([1](#), [2](#)).

Références pour l'évaluation

1. [Boden SD, Davis DO, Dina TS, Patronas NJ, Wiesel SW](#). Abnormal magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects. A prospective investigation. *J Bone Joint Surg Am*. 1990;72(3):403-408.
2. [Jensen MC, Brant-Zawadzki MN, Obuchowski N, Modic MT, Malkasian D, Ross JS](#). Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in people without back pain. *N Engl J Med*. 1994;331(2):69-73. doi:10.1056/NEJM199407143310201

Traitement des douleurs du cou et du dos

Les troubles sous-jacents sont traités.

La douleur musculosquelettique aiguë (avec ou sans radiculopathie) est traitée par

- Modification de l'activité
- Antalgiques
- Chaleur et froid
- Stabilisation et exercices lombaires
- Réconfort

Chez les patients qui ont une douleur dorsale aiguë non spécifique (non radiculaire), douleur du cou ou du bas du dos, le traitement peut être démarré sans évaluation approfondie pour identifier une étiologie spécifique (1).

Pièges à éviter

- Traiter symptomatiquement les patients qui ont des douleurs dorsales non spécifiques et non radiculaires qui ne présentent aucun symptôme inquiétant, sans nécessiter une évaluation initiale.

Modification de l'activité

Bien qu'une brève période initiale (p. ex., jusqu'à 48 h) de diminution de l'activité soit parfois nécessaire pour améliorer le confort, l'alitement prolongé, les tractions rachidiennes et des corsets sont inutiles. Les patients qui ont des douleurs cervicales peuvent tirer profit de l'utilisation nocturne d'une minerve cervicale et d'un oreiller contour pour dormir. Lorsque la douleur disparaît, les patients peuvent participer à un programme de stabilisation.

Antalgiques

Le paracétamol ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont le choix initial des antalgiques. Rarement des [opioïdes](#) peuvent être nécessaires avec les précautions appropriées pour les douleurs sévères et aiguës. Une analgésie adéquate est importante immédiatement après une lésion aiguë, pour

permettre de limiter le cycle douleur-spasme. Les preuves des bénéfices de l'utilisation chronique sont faibles ou absents, ainsi la durée d'utilisation d'opioïdes doit être limitée.

Chaleur et froid

Les spasmes ou contractures aiguës d'origine musculaire, peuvent également être soulagés par le froid ou chaleur. Le froid est habituellement préféré à la chaleur pendant les 2 premiers jours après une blessure. La glace et les compresses froides ne doivent pas être directement appliquées sur la peau. Elles doivent être emballées dans des sacs (p. ex., en plastique) et placées sur une serviette ou des vêtements. La glace est retirée après 20 min, puis ultérieurement réappliquée pendant 20 min sur une période de 60 à 90 min. Ce processus peut être répété plusieurs fois pendant les 24 premières heures. La chaleur, en utilisant un coussin chauffant, peut être appliquée pendant la même période de temps. Puisque la peau du dos peut être insensible à la chaleur, le chauffage par des pansements chauds doit être effectué avec précautions pour éviter les brûlures. Il est recommandé aux malades de ne pas utiliser un coussin chauffant au coucher afin d'éviter une exposition prolongée due à l'endormissement avec le pansement chauffant encore sur leur dos.

Stabilisation et exercices lombaires et cervicaux

Lorsque la douleur aiguë aura diminué suffisamment et que le mouvement sera possible, un programme de stabilisation cervicale ou lombaire est débuté sous la supervision d'un kinésithérapeute. Ce programme doit être débuté dès que possible et comprend la restauration des mouvements, des exercices de renforcement des muscles paraspinaux et en association avec une formation aux postures de travail; l'objectif est de renforcer les structures de soutien du dos et de réduire le risque que le trouble ne devienne chronique ou récidivant. En cas de douleur du bas du dos, le renforcement des muscles «essentiels» (abdominaux et du bas du dos) est important et commence souvent par une progression allant du travail sur une table en décubitus ou en décubitus ventral, en quadrupède (à quatre pattes) et enfin en position debout.

Réconfort

Les médecins doivent rassurer les patients qui présentent une douleur musculosquelettique non spécifique aiguë car le pronostic est généralement favorable et parce que l'activité et l'exercice sont sans danger même lorsqu'ils provoquent une certaine gêne. Une éducation appropriée du patient peut également permettre de réduire les soins inutiles (2).

Autres modalités de traitement

Les preuves en faveur de l'efficacité des **corticostéroïdes** oraux et injectés (p. ex., les injections épidurales spinales et facettaires [3]) sont limitées. Certaines données suggèrent qu'un cycle de corticostéroïdes oraux peut entraîner une légère amélioration à court terme de la douleur chez certains patients qui ont une lombalgie radiculaire; cependant, les corticostéroïdes oraux sont susceptibles d'être inefficaces en cas de lombalgie non radiculaire (4). Les injections épidurales de corticostéroïdes en cas de [lombalgie radiculaire](#) doivent être réservées aux patients qui ne se sont pas améliorés par d'autres modalités de traitement. Si une injection épidurale ou des articulations facettaires de

corticostéroïdes est prévue, il convient de pratiquer une IRM avant l'injection afin que la pathologie puisse être identifiée, localisée et traitée de façon optimale.

La **dénervation par radiofréquence** est une autre technique qui a été utilisée chez les patients présentant une douleur à médiation articulaire facettaire non radiculaire, avec des preuves en faveur d'une amélioration de la douleur et de la fonctionnalité par rapport au placebo (5). Une injection dans le nerf spinal dorsal, un bloc de branche interne ou un anesthésique est effectuée pour évaluer la réponse potentielle du patient avant radiofréquence.

L'utilisation des **myorelaxants** (p. ex., cyclobenzaprine, méthocarbamol, métaxalone, benzodiazépines) pour les douleurs cervicales et lombaires est controversée. Les bénéfices de ces médicaments doivent être mis en balance avec leurs effets sur le système nerveux central et d'autres effets indésirables, en particulier chez les patients âgés, qui ont de plus sévères effets négatifs (6). Les myorelaxants doivent être réservés aux patients présentant des spasmes musculaires visibles et palpables et ne doivent pas être utilisés pendant plus de 72 heures, sauf chez certains patients atteints de syndrome douloureux central (p. ex., [fibromyalgie](#)) chez lesquels la cyclobenzaprine nocturne peut améliorer la qualité du sommeil et réduire la douleur.

Les **manipulations rachidiennes** permettent de soulager la douleur provoquée par un spasme musculaire ou un traumatisme aigu du cou ou du dos; cependant, les manipulations à haute vitesse peuvent être dangereuses chez les patients âgés (p. ex., lésion de l'artère vertébrale lors de manipulations du cou) et les sujets atteints de troubles discaux sévères, d'[arthrite](#) cervicale, de [sténose cervicale](#) ou d'[ostéoporose](#).

Références pour le traitement

1. [Qaseem A, Wilt TJ, McLean RM, et al.](#) Noninvasive Treatments for Acute, Subacute, and Chronic Low Back Pain: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians. *Ann Intern Med.* 2017;166(7):514-530. doi:10.7326/M16-2367
2. [Traeger AC, Hübscher M, Henschke N, Moseley GL, Lee H, McAuley JH.](#) Effect of Primary Care-Based Education on Reassurance in Patients With Acute Low Back Pain: Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Intern Med.* 2015;175(5):733-743. doi:10.1001/jamainternmed.2015.0217
3. [Vekaria R, Bhatt R, Ellard DR, Henschke N, Underwood M, Sandhu H.](#) Intra-articular facet joint injections for low back pain: a systematic review. *Eur Spine J.* 2016;25(4):1266-1281. doi:10.1007/s00586-016-4455-y
4. [Chou R, Pinto RZ, Fu R, et al.](#) Systemic corticosteroids for radicular and non-radicular low back pain. *Cochrane Database Syst Rev.* 2022;10(10):CD012450. Published 2022 Oct 21. doi:10.1002/14651858.CD012450.pub2
5. [Poetscher AW, Gentil AF, Lenza M, Ferretti M.](#) Radiofrequency denervation for facet joint low back pain: a systematic review. *Spine (Phila Pa 1976).* 2014;39(14):E842-E849. doi:10.1097/BRS.0000000000000337
6. [Cashin AG, Wand BM, O'Connell NE, et al.](#) Pharmacological treatments for low back pain in adults: an overview of Cochrane Reviews. *Cochrane Database Syst Rev.* 2023;4(4):CD013815. Published 2023 Apr 4. doi:10.1002/14651858.CD013815.pub2

Bases de gériatrie: douleurs cervicales et lombaires

Les douleurs lombaires touchent presque 50% des adultes de ≥ 65 ans (1).

L'[anévrisme de l'aorte abdominale](#) (et la TDM ou l'échographie pour le détecter) doit être envisagé chez le patient âgé présentant une douleur dorsale basse, sans traumatisme, en particulier celui qui a fumé ou présente une HTA, même si aucun signe clinique n'est en faveur de ce diagnostic.

L'imagerie de la colonne peut être utile chez les personnes âgées (p. ex., pour éliminer un cancer) même lorsque la cause semble en être des douleurs musculosquelettiques non compliquées.

L'utilisation des relaxants musculaires oraux (p. ex., cyclobenzaprine, méthocarbamol, métaxalone) et d'opioïdes sont controversés; les effets anticholinergiques, sur le système nerveux central et d'autres effets indésirables peuvent surpasser les bénéfices potentiels chez les patients âgés.

Références pour les bases de gériatrie

1. [Lucas JW, Connor EM, Bose J](#). Back, Lower Limb, and Upper Limb Pain Among U.S. Adults, 2019. *NCHS Data Brief*. 2021;(415):1-8.

Points clés

- Près de 50% des adultes de ≥ 65 ans souffrent de lombalgies basses.
- La plupart des douleurs du cou et des régions lombaires sont provoquées par des pathologies mécaniques du rachis, habituellement non spécifiques, trouble musculosquelettique autolimité.
- Le mal de dos est souvent multifactoriel, rendant difficile l'identification d'une étiologie spécifique.
- Les signes d'imagerie ne sont pas toujours corrélés avec les symptômes du patient.
- Bien que les troubles rachidiens ou extrarachidiens graves soient des causes inhabituelles, des signes d'alarme indiquent souvent la nécessité de pratiquer des tests.
- L'évaluation de la fonction de la moelle épinière lors de l'examen clinique comprend des tests de la fonction du nerf sacré (p. ex., tonus rectal, réflexe anal, réflexe bulbocaverneux), des réflexes du genou et de la cheville et de la force motrice.
- Les patients présentant des déficits neurologiques systématisés qui suggèrent une compression de la moelle épinière doivent subir une IRM ou une myélo-TDM dès que possible.
- L'anévrisme de l'aorte abdominale doit être évoqué chez tout patient âgé présentant une douleur du dos qui n'est pas clairement mécanique, même si aucun signe clinique ne suggère ce diagnostic.



Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, États-Unis et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.